

LIBERACIÓN MIOFASCIAL (MYOFASCIAL RELEASE)

Masoterapia II

Semana 07

Iniciamos en breve...

Presente.

LIBERACIÓN MIOFASCIAL (MYOFASCIAL RELEASE)

Masoterapia II

Semana 07

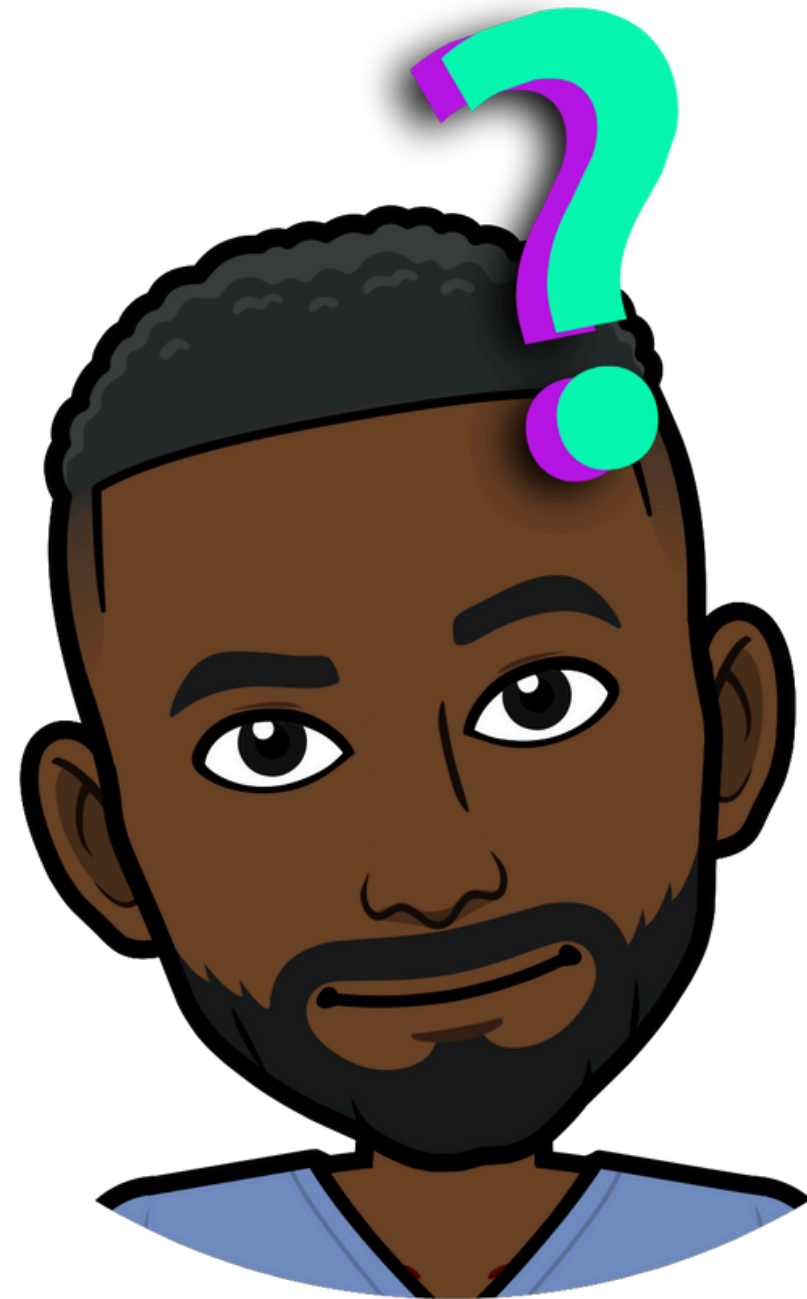
LIC. BLADIMIR ORTIZ C.

Presente.

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

- Definir qué es la fascia y explicar su función en el movimiento y el dolor.
- Comprender el concepto de restricción miofascial y su impacto clínico.
- Diferenciar la liberación miofascial de otras técnicas manuales.
- Reconocer los principios fundamentales de la movilización miofascial.
- Aplicar técnicas básicas de liberación miofascial de forma segura y consciente.
- Integrar la liberación miofascial como técnica complementaria en masoterapia.





Preguntas de Reflexión:

1. ¿Qué es lo que realmente se estira cuando “estiramos un músculo”?
2. ¿Por qué algunos dolores persisten aunque el músculo ya no esté contracturado?
3. ¿Has sentido zonas “duras”, “pegadas” o rígidas que no responden al masaje común?
4. ¿Puede el tejido conectivo influir en el dolor crónico?

1. ¿QUÉ ES LA FASCIA?

La fascia es un tejido conectivo continuo, tridimensional y dinámico que envuelve, separa y conecta todas las estructuras del cuerpo humano: músculos, huesos, nervios, vasos sanguíneos y órganos.

👉 No es un tejido pasivo.

👉 Es un sistema de comunicación mecánica y sensorial.

📌 Características principales:

- Forma una red continua en todo el cuerpo.
- Tiene capacidad de adaptación (plasticidad).
- Es sensible al estrés mecánico, postural y emocional.
- Contiene gran cantidad de receptores sensoriales.

2. TIPOS DE FASCIA

◆ Fascia superficial

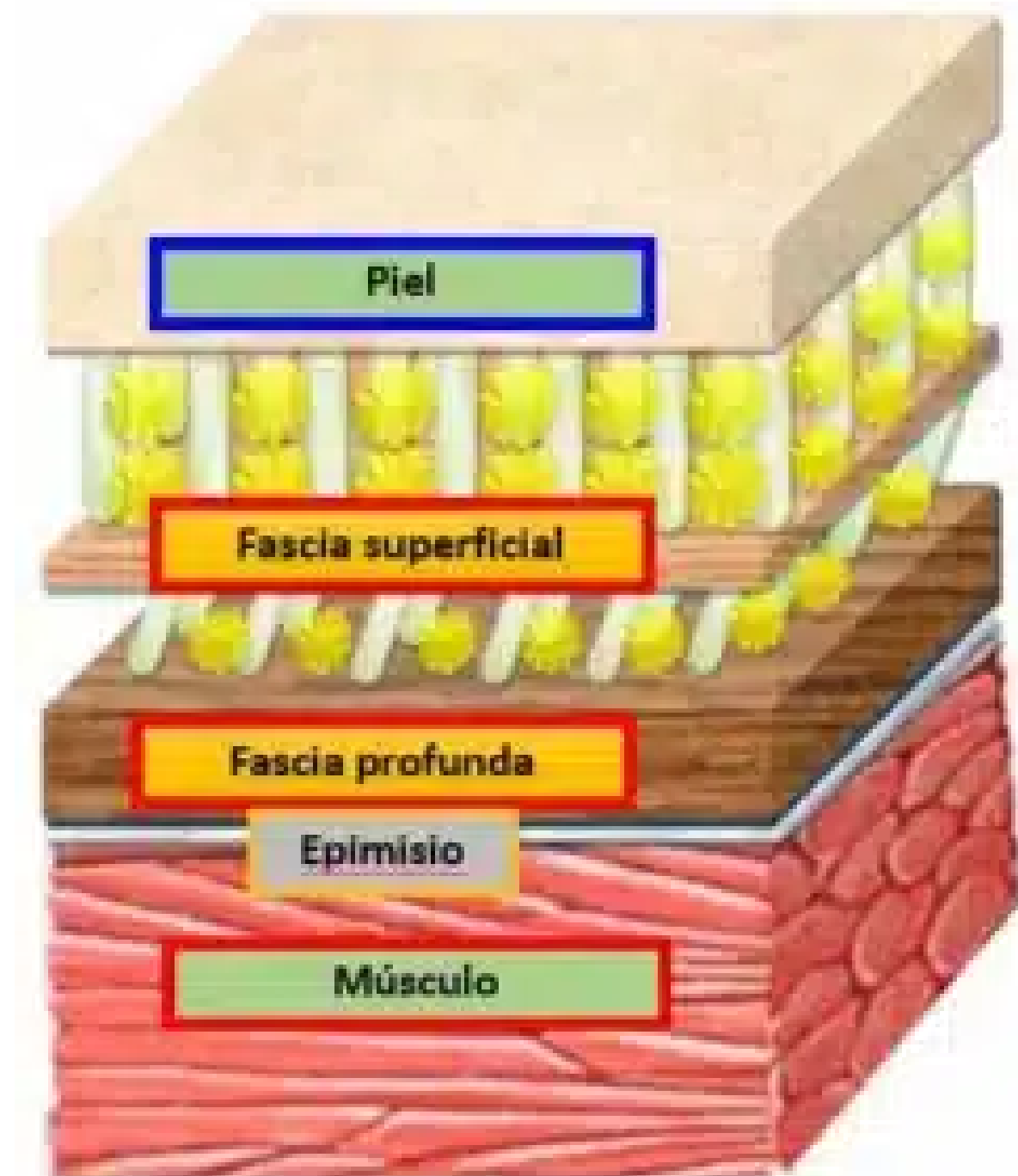
- Debajo de la piel.
- Relacionada con la circulación y temperatura.
- Importante en drenaje y movilidad cutánea.

◆ Fascia profunda

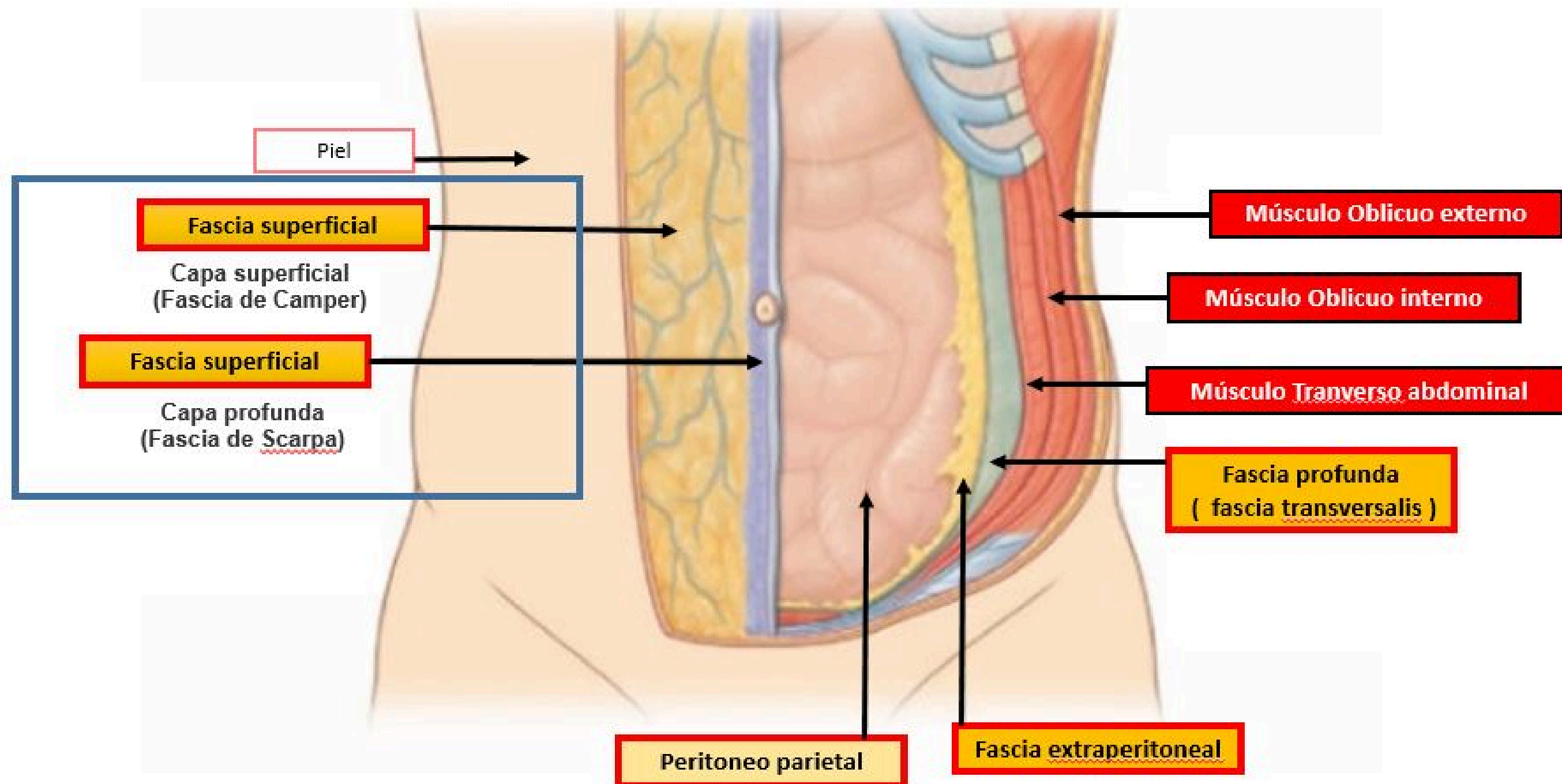
- Envuelve músculos, grupos musculares y huesos.
- Transmite fuerza y coordina movimiento.
- Principal foco de la liberación miofascial.

◆ Fascia visceral

- Sostiene y conecta órganos internos.
- Relacionada con postura y dolor referido.



2. TIPOS DE FASCIA



3. FUNCIONES DE LA FASCIA

- Soporte estructural.
- Transmisión de fuerzas.
- Coordinación del movimiento.
- Propiocepción (conciencia corporal).
- Protección de estructuras.
- Participación en el dolor crónico.



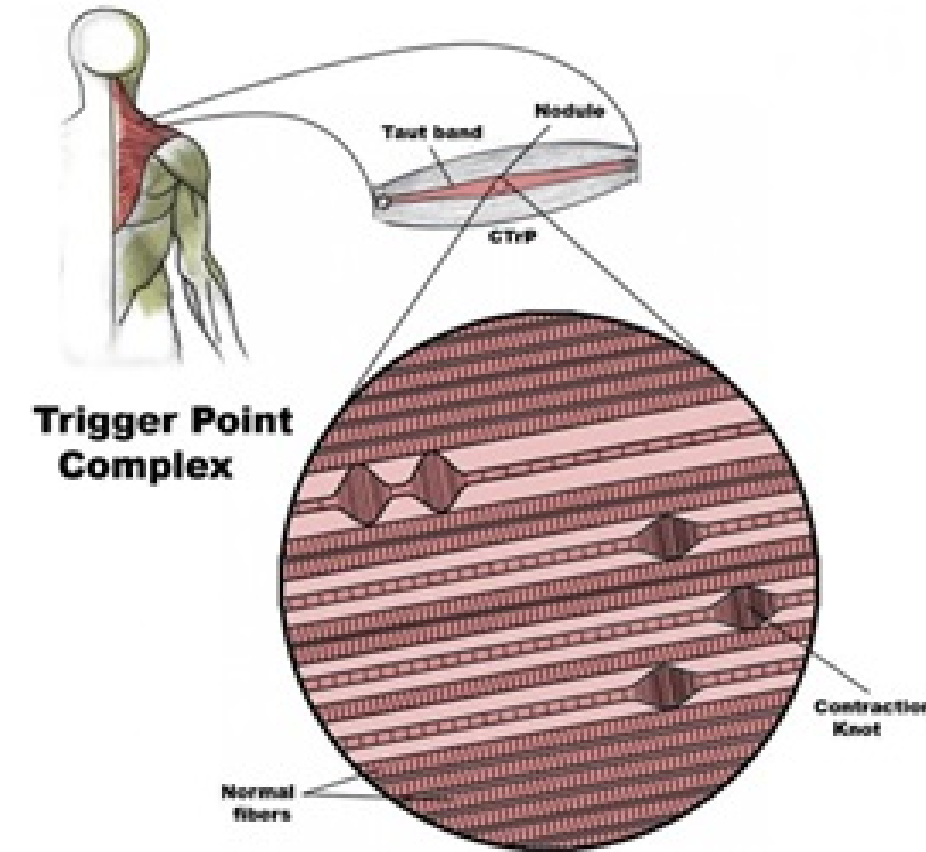
📌 Importante:

Muchas disfunciones atribuidas al “músculo” son en realidad fasciales.

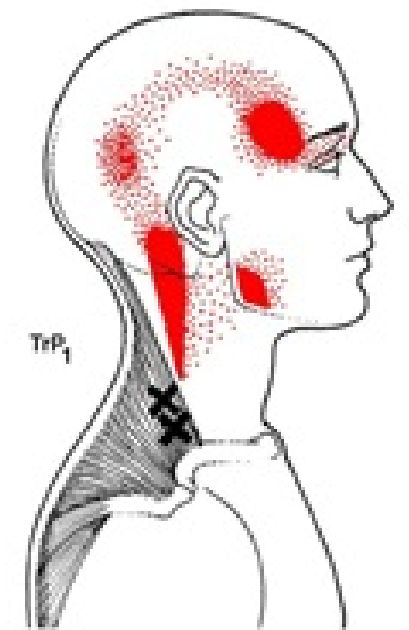
4. ¿QUÉ ES UNA RESTRICCIÓN MIOFASCIAL?

Es una pérdida de movilidad, elasticidad o deslizamiento de la fascia, que genera:

- Dolor local o referido.
- Rigidez.
- Limitación del movimiento.
- Sensación de “tirantez” constante.
- Alteraciones posturales.



Banda muscular contracturada. La ilustración muestra los pequeños nódulos contracturados de 1mm de tamaño.



Cuadro de dolor irradiado de un punto gatillo del trapecio.

4. ¿QUÉ ES UNA RESTRICCIÓN MIOFASCIAL?

🧩 Causas frecuentes:

- Posturas prolongadas.
- Microtraumatismos repetitivos.
- Cirugías y cicatrices.
- Estrés emocional.
- Sedentarismo.
- Sobrecarga deportiva.



5. ¿QUÉ ES LA LIBERACIÓN MIOFASCIAL?

La liberación miofascial (MFR) es una técnica manual que aplica presión lenta, sostenida y específica sobre el tejido fascial con el objetivo de:

- Restaurar movilidad.
- Reducir dolor.
- Liberar adherencias.
- Mejorar función y postura.

👉 No busca fuerza.

👉 Busca respuesta del tejido.



6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LIBERACIÓN MIOFASCIAL

1. Presión lenta y sostenida (30 segundos a 3 minutos).
2. Sin uso de aceite (necesitamos fricción).
3. Escucha del tejido, no imposición.
4. Respiración consciente.
5. Paciencia: la fascia necesita tiempo.
6. Respeto del umbral de dolor (nunca dolor intenso).



7. DIFERENCIA ENTRE MASAJE Y LIBERACIÓN MIOFASCIAL

Masaje Tradicional

- Movimientos rítmicos
- Uso de aceite
- Enfoque muscular
- Ritmo más rápido
- Efecto inmediato



Liberación Miofascial

- Presión sostenida
- Sin aceite
- Enfoque fascial
- Ritmo lento
- Efecto progresivo

8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

◆ Técnicas directas:

- Se aplica presión hacia la restricción.
- Busca elongar el tejido fascial.

Ejemplo: estiramiento profundo sostenido.



8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES



- ◆ **Técnicas indirectas**
 - Se lleva el tejido hacia la comodidad.
 - El cuerpo libera espontáneamente.
 - Ideal para pacientes sensibles.

8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

1. DESLIZAMIENTO EN FORMA DE "J"



8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

2. DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL



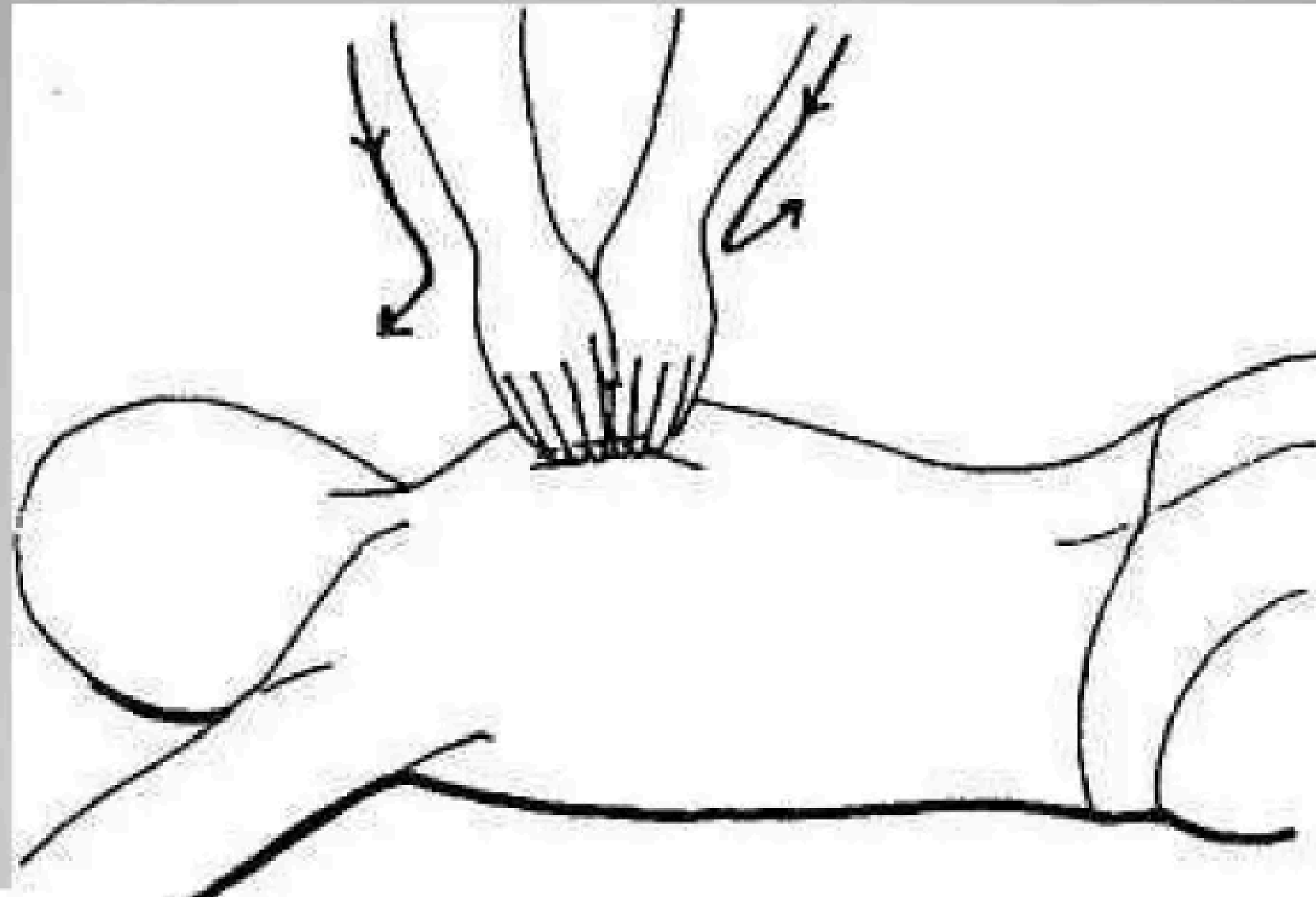
8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

2. DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL



8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

3. DESLIZAMIENTO TRANSVERSO



8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES



8. TIPOS DE TÉCNICAS MIOFASCIALES

2. PLANOS TRANSVERSOS



9. SENSACIONES DURANTE LA LIBERACIÓN

El paciente puede sentir:

- Calor local.
- Pulsación.
- “Derretimiento” del tejido.
- Relajación profunda.
- Cambio en respiración.

Estas sensaciones indican respuesta fascial.



10. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

- ✓ Dolor crónico
- ✓ Contracturas persistentes
- ✓ Lumbalgia, cervicalgia
- ✓ Fascitis plantar
- ✓ Restricciones de movilidad
- ✓ Cicatrices (no recientes)
- ✓ Estrés corporal generalizado

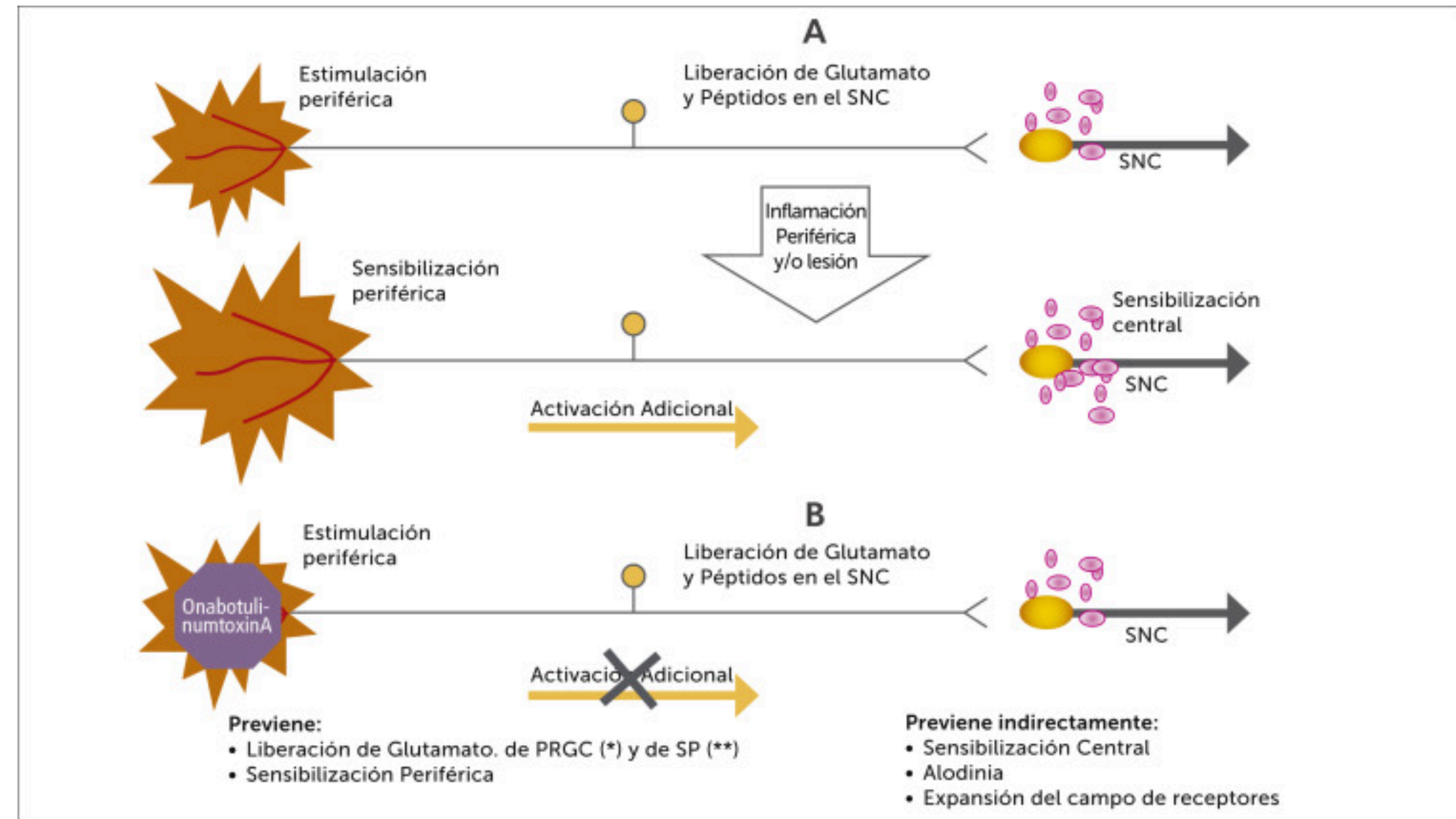
- ✗ Inflamación aguda
- ✗ Infecciones
- ✗ Trombosis
- ✗ Heridas abiertas
- ✗ Hematomas recientes
- ✗ Fiebre
- ✗ Cáncer activo (sin indicación médica)

11. NEUROFISIOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN MIOFASCIAL

🎯 ¿POR QUÉ LA LIBERACIÓN MIOFASCIAL FUNCIONA?

No solo actúa a nivel mecánico, sino principalmente a nivel neurológico.

👉 El efecto terapéutico se produce por la interacción entre el sistema nervioso y la fascia.



12. LA FASCIA COMO ÓRGANO SENSORIAL

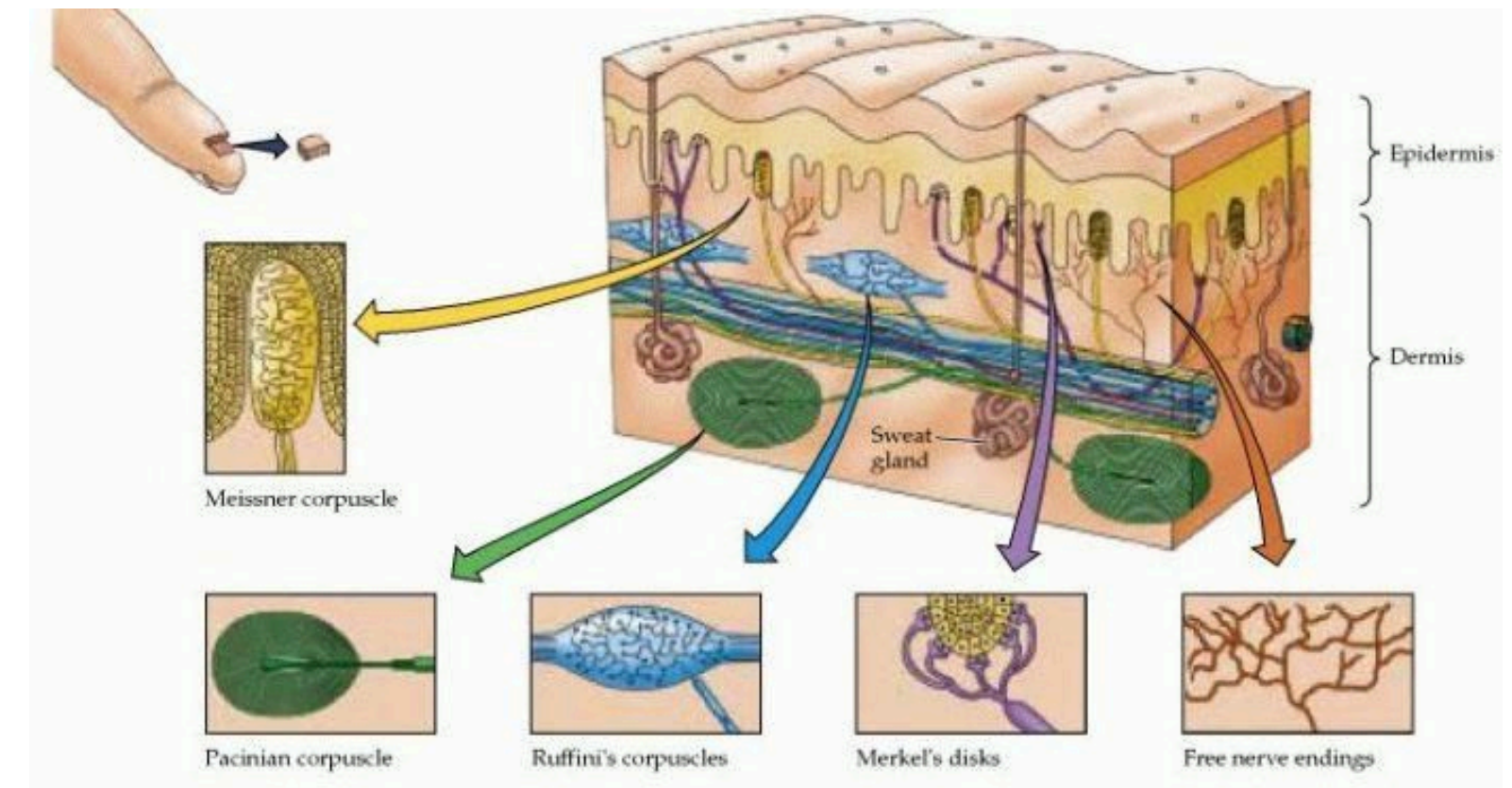
La fascia es uno de los tejidos con mayor densidad de receptores sensoriales del cuerpo humano.

📌 Receptores presentes en la fascia:

- Mecanorreceptores
- Propioceptores
- Nociceptores
- Interoceptores

Esto explica por qué:

- ✓ La fascia “siente”
- ✓ La fascia “recuerda”
- ✓ La fascia “responde” a estímulos lentos



13. MECANORRECEPTORES FASCIALES Y SU FUNCIÓN

- ◆ Ruffini
 - Responden a presión lenta y sostenida.
 - Inhiben el sistema nervioso simpático.
 - Favorecen relajación y disminución del tono.
- Activados directamente por la liberación miofascial.



13. MECANORRECEPTORES FASCIALES Y SU FUNCIÓN

◆ Pacini

- Responden a cambios rápidos de presión.
- Relacionados con movimiento y vibración.
- No son el objetivo principal del MFR.

◆ Husos musculares (indirectamente)

- Detectan cambios de longitud muscular.
- Presión lenta reduce reflejo de estiramiento.

◆ Órganos tendinosos de Golgi

- Detectan tensión.
- Favorecen inhibición muscular refleja.
- Contribuyen a la relajación profunda.



14. EFECTO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

La liberación miofascial tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso autónomo.

▼ **Disminuye:**

- Activación simpática (estrés, alerta).
- Hipertonía muscular.
- Dolor crónico.

▲ **Aumenta:**

- Activación parasimpática.
- Relajación profunda.
- Respiración diafragmática.

📌 **Por eso muchos pacientes:**

- Suspiran
- Bostezan
- Se relajan profundamente
- Refieren sensación de “descarga”

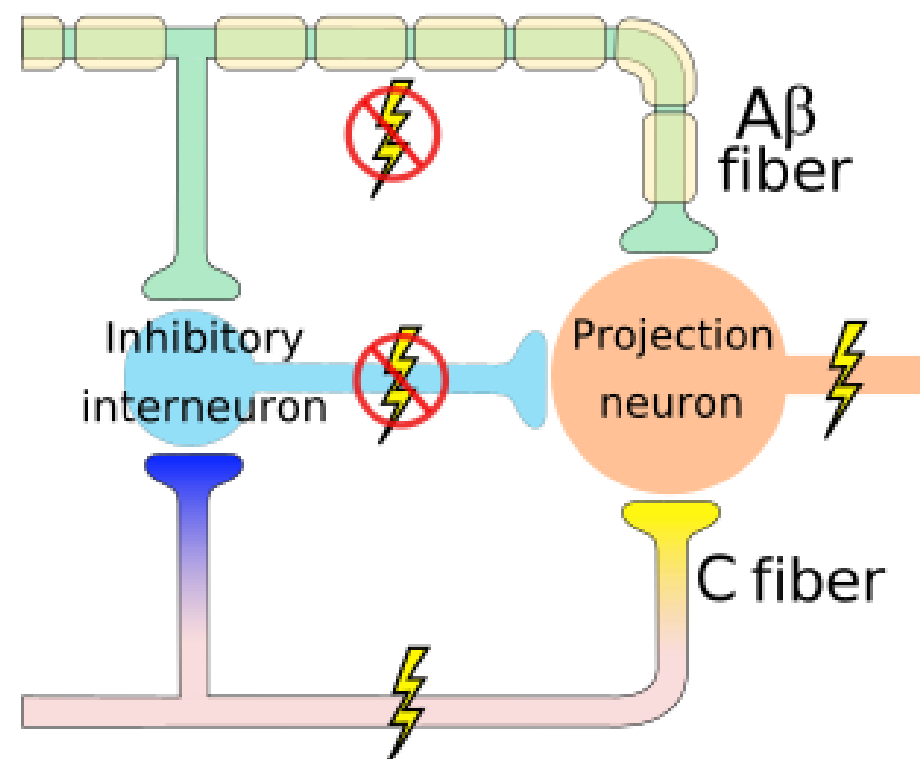


15. MODULACIÓN DEL DOLOR (NEUROMODULACIÓN)

✚ Teoría de la compuerta del dolor (Gate Control)

La presión lenta y profunda:

- Estimula fibras A-beta (no dolorosas).
- Inhibe la transmisión del dolor en médula espinal.
- Reduce la percepción del dolor.



🧠 Liberación miofascial y dolor crónico

En dolor crónico:

- El sistema nervioso está hipersensibilizado.
- La fascia se vuelve rígida y reactiva.

La liberación miofascial:

- ✓ Disminuye la hipersensibilidad
- ✓ “Reeduca” la respuesta del sistema nervioso
- ✓ Reduce el umbral del dolor

16. RESPIRACIÓN Y SISTEMA NERVIOSO



La presión sostenida combinada con respiración:

- Estimula el nervio vago.
- Reduce frecuencia cardíaca.
- Mejora variabilidad de la frecuencia cardíaca.
 - Facilita la liberación fascial.

👉 Respirar lento = liberar mejor.

17. MEMORIA SOMÁTICA Y FASCIA

La fascia está implicada en la memoria corporal.

- Traumas físicos o emocionales generan patrones tensionales.

La liberación lenta permite que el cuerpo:

- Reconozca
- Libere
- Reorganice

📌 **Esto explica reacciones emocionales leves durante la terapia.**



18. POR QUÉ LA PRESIÓN DEBE SER LENTA

Si la presión es rápida:

- ✗ Se activa defensa muscular
- ✗ Aumenta tono
- ✗ No hay liberación

Si la presión es lenta:

- ✓ Se activa inhibición neurológica
- ✓ Se relaja el tejido
- ✓ Se produce liberación fascial



18. IMPLICANCIA PARA EL TERAPEUTA

El terapeuta debe:

- Mantener presencia y atención.
- Sentir el cambio del tejido.
- Respetar tiempos neurológicos.
- Evitar “forzar” la liberación.

👉 **La fascia responde al sistema nervioso, no a la fuerza.**



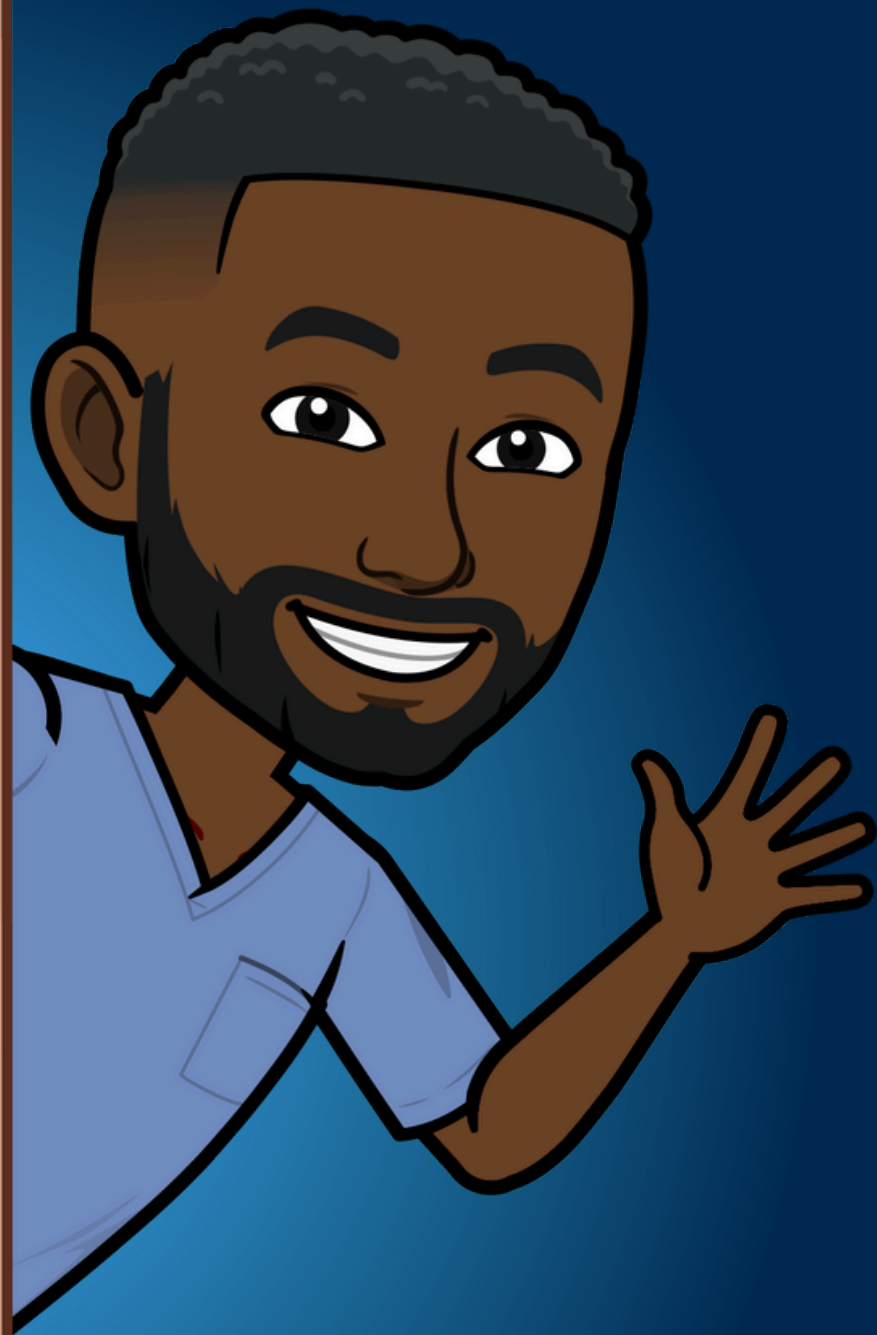
CONCLUSIONES CLAVE

- 1. La fascia es un tejido clave en el movimiento y el dolor.*
- 2. Muchas disfunciones musculares tienen origen fascial.*
- 3. La liberación miofascial requiere tiempo, escucha y sensibilidad.*
- 4. No es fuerza, es intención terapéutica.*
- 5. Es una técnica altamente complementaria a la masoterapia.*
- 6. Su correcta aplicación mejora resultados clínicos a largo plazo.*

Rúbrica

Criterio	Descripción	Puntaje
1. Localización correcta de los puntos.	Identifica puntos con precisión anatómica.	6 pts
2. Técnica de presión.	Presión gradual, sostenida y correcta dosificación.	4 pts
3. Ritmo y respiración.	Coordinación adecuada, sin interrupciones.	3 pts
4. Ergonomía y postura.	Posición estable, hombros relajados, alineación correcta.	3 pts
5. Actitud profesional.	Respeto, comunicación y manejo terapéutico apropiado.	2 pts
6. Evidencia de práctica.	Foto o video corto (20–30 seg).	2 pts
TOTAL		20 pts

NOS VEMOS LA PRÓXIMA!!



Presente.